

笑顔と感動にあふれる
病院を目指します



食事と栄養療法コース 令和8年8月27日（木）

臨床栄養管理(食事の基本)

名古屋市立大学病院
栄養管理科 山田 悠史

- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

思い出してみよう！①

➤ 三色食品群

赤 … 血や肉をつくるもの
魚・肉・大豆・牛乳・卵

黄 … 力や体温となるもの
穀物・砂糖・油脂・いも

緑 … からだの調子をよくするもの
野菜・海草・きのこ

➤ 六つの基礎食品群

1 群：魚、肉、卵、大豆

2 群：牛乳・乳製品、海草、小魚

3 群：緑黄色野菜

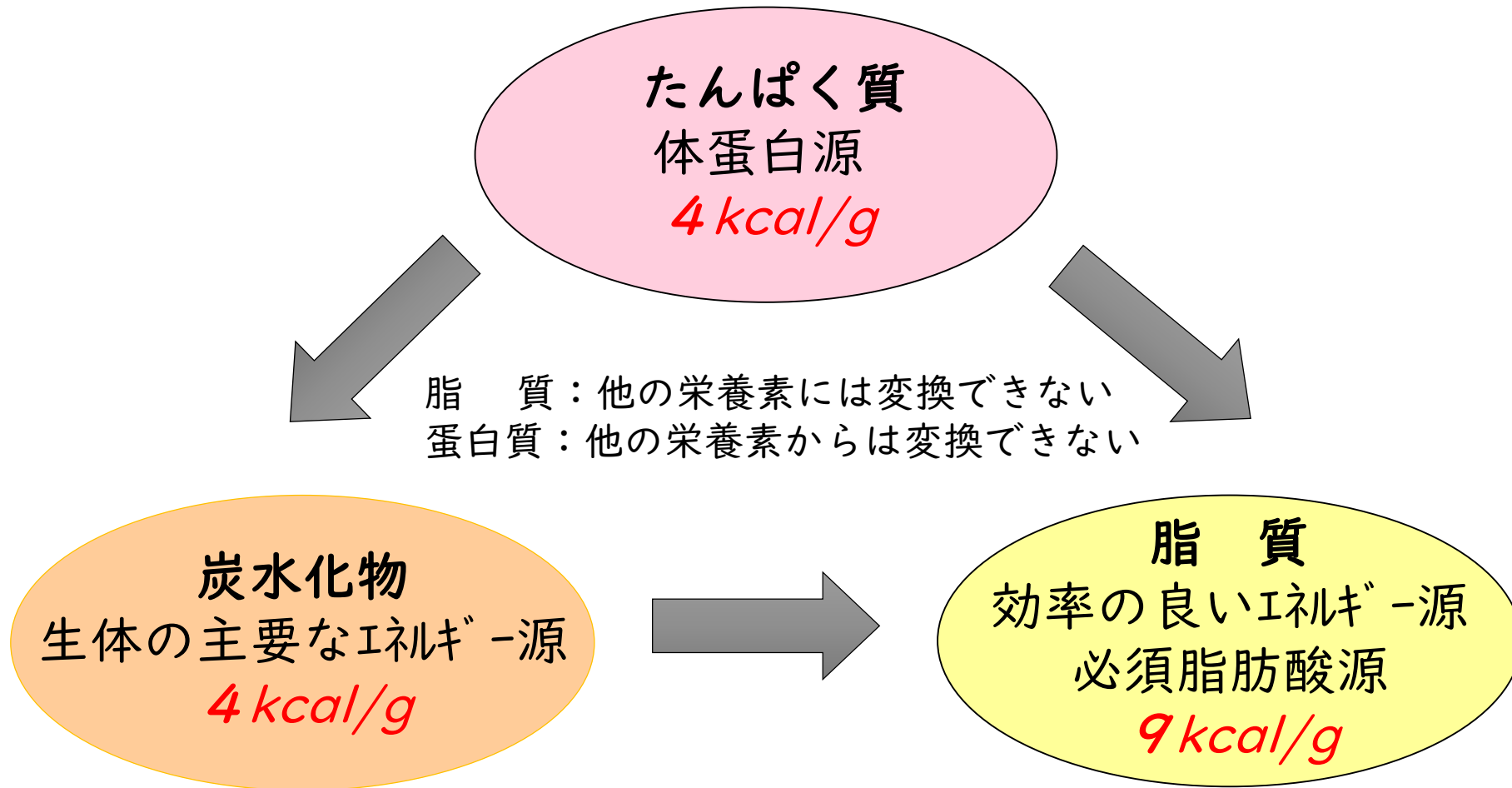
4 群：淡色野菜、果物

5 群：穀類、いも類、砂糖

6 群：油脂類 脂肪の多い食品

思い出してみよう! ②

三大栄養素



1 g 当たりのエネルギー量：アトウォーターのエネルギー換算係数を使用

ごはん 100g のエネルギーは？

炭水化物
37.1g



脂 質
0.3g

たんぱく質
2.5g

エネルギー (kcal) は？

$$(37.1g + 2.5g) \times 4kcal + 0.3g \times 9kcal \div 160kcal$$

塩分摂取の目標値（1日当たり）

- 健康日本21（第2次） [厚生労働省]

8.0 g 未満

- 日本人の食事摂取基準（2025年版） [厚生労働省]

成人男性 7.5 g 未満

成人女性 6.5 g 未満

- 高血圧治療のガイドライン2004～ [日本高血圧学会]

6 g 未満

- ☆ WHOのNa摂取量に関するガイドライン（2012年）

一般成人 5 g 以下（Na 2,000mg以下）

食塩摂取量年次推移（国民健康・栄養調査結果）

年次（西暦）	全体	男性	女性
20年（2008）	10.9	11.9	10.1
25年（2013）	10.2	11.1	9.4
30年（2018）	10.1	11.0	9.3
R1年（2019）	10.1	10.9	9.3
R4年（2022）	9.7	10.5	9.0
R5年（2023）	9.8	10.7	9.1
R6年（2024）★最新	9.6	10.5	8.9

最新（令和6年）の結果

9.6 g/日

平均摂取量は過去12年間で最低値を記録。

男性: 10.5g

女性: 8.9g

※令和2年(2020)・令和3年(2021)は新型コロナ影響により調査中止

塩分量クイズ！！

どれが一番塩分量が低いでしょうか？



A 寿司 1人前



B ラーメン



C 牛丼(並)

栄養成分表示を確認して塩分量を知る

100gあたり

食品栄養成分表

エネルギー	190kcal
タンパク質	7.4g
脂質	10.6 g
炭水化物	16.6 g
ナトリウム	400mg
食塩相当量	1.0g

- ナトリウムを塩分に換算する方法

$$\frac{\text{ナトリウム量 (mg)} \times 2.54 \div 1,000}{= \text{食塩相当量 (g)}}$$

$$400(\text{mg}) \times 2.54 \div 1.000 = 1.016 \\ \div 1 \text{ g}$$

ナトリウム量 約400mg

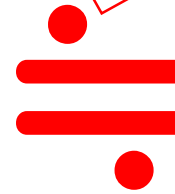
= 食塩相当量 **1g**

野菜の摂取目標量とエネルギー量

野菜は1日350gが目標



約100kcalで同じ



にぎり寿司2貫
(マグロ赤身)

野菜は低エネルギーの食材

野菜摂取量

どのくらい摂っているでしょう？



愛知県



- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

身長・体重・生活活動強度(安静度)・疾病の種類・病態・食物の摂取能力(咀嚼・嚥下の状態)などを総合的に考慮した食事

食事は 治療の一環 として提供されるべきもの
食事の質の向上と患者サービスの改善も求められる



病院食の分類

一般食	普通食（常食ともいう）
	軟 食（全粥、5分粥など）
	流動食（経腸栄養剤、重湯など）
特別食	加算食※ （糖尿病食、腎臓病食など）
	非加算食 （嚥下調整食、離乳食など）

※ 社会保険診療報酬において特別食加算が付く食種

疾病治療の直接手段として、**医師の発行する食事せん**に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する治療食。

<治療食>

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、検査食（単なる流動食及び軟食を除く）

入院時 食事療養費 (Ⅰ)	(Ⅰ) (Ⅱ) 以外の食事療養を行う場合	730円/食
	(Ⅱ) 流動食のみを提供する場合	665円/食
特別食加算		76円/食

☆ 流動食のみを提供する場合

食事療養として流動食(市販されているものに限る)のみを
経管栄養法により提供したときに1日3食を限度として算定

入院時食事療養費の見直しについて

2026年3月制作

【改正の内容】

昨今の物価高騰の影響で、給食材料費や調理費(光熱水費)などは上昇し続けています。このような状況を踏まえ、令和8年6月1日から食事療養費が690円から730円へ改定されます。**物価高騰などの影響を踏まえた改定となりますので、食事内容(メニュー)やサービスに大幅な変更はありません。**ご理解の程よろしくお願い申し上げます。



入院時
食事療養
(I)

特別食加

☆ 流動食

食事

経管

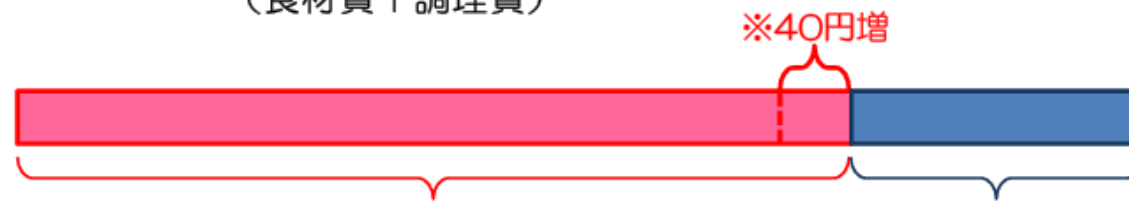
令和7年4月1日～



自己負担510円
(食材費+調理費)

保険給付180円

令和8年6月1日～



自己負担550円
(食材費+調理費)

保険給付180円

※40円増



(公社)日本栄養士会 医療事業推進委員会

※ 低所得者は除く

食事箋



医師の発行する食事指示書（食事オーダー）

⇒ 医師の署名捺印されたものを原則とするが、オーダリングシステム等により、医師本人の指示によるものが確認できるものについても認めるものとする。

約束食事箋

食種の栄養基準量をまとめた帳票



⇒ 食事栄養基準集（名古屋市立大学病院での名称）

疾患別栄養管理 と 成分別栄養管理 の2種類の方式がある！

疾患別栄養管理

「糖尿病食」 「腎臓病食」 「肝臓病食」 「心臓病食」

成分別栄養管理

「エネルギーコントロール食」 「たんぱく質コントロール食」
「脂質コントロール食」

疾患別分類 と 成分別分類

	エネルギー コントロール食	たんぱく質 コントロール食	脂 質 コントロール食
糖尿病食	○		
腎臓病食		○	
心臓病食	○ + 塩分制限		
肝臓病食	○	○	○

- ① 自然治癒力を増進
- ② 病態の改善や疾病の良好なコントロール
- ③ ターミナルケアの重要な一部

- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

糖尿病とは

慢性的に高血糖が持続する疾患

原因：インスリン分泌障害、インスリン抵抗性亢進

分類：1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病などがある

1型糖尿病

膵臓の β 細胞が破壊されてインスリンが欠乏が生じて発症 多くは小児期

ほとんどが、インスリン導入を余儀なくされる



2型糖尿病

一般的に糖尿病を指すもの 中高年に多い

遺伝的素因と生活習慣により、主にインスリン分泌低下にインスリン抵抗性が加わることで発症

糖尿病の食事療法

望ましい食習慣とともに過食を避け、偏食せずに、規則正しい食事をする事

➡ 血糖のコントロールをよくし、合併症防止
健康で長生きするための食生活の原則

適正なエネルギー量の食事

栄養素のバランスがよい食事

《合併症予防》

食塩を減らす

コレステロールや飽和脂肪酸を多く含む食品を控える

食物繊維を増加させる

- ☆ 1日の総摂取エネルギー別に調整された食事
- ☆ 各エネルギーごとに、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルのバランスを考えたもの

適応疾患

①制限的に用いる場合

糖尿病、肥満症、脂肪肝、急性肝炎、**心臓病**など

②一般食の栄養基準程度の場合

慢性肝炎、**肝硬変（代償期）**、**高血圧症**、痛風、貧血など

③高エネルギー食として用いる場合

甲状腺機能亢進症、神経性食思不振症など

600kcal/食



ご飯
酢豚
なすのスープ煮
果物（柿）

※赤字：塩分制限が必要

① 標準体重を求める！

例) 身長は? 160 cm $\Rightarrow$ 1.6 m

$$1.6\text{m} \times 1.6\text{m} \times 22 \div 56.3 \text{ kg}$$

BMI (体格指数)

※ 自分の体重を測定し、+10%以内におさまるようにしましょう。

② 総摂取エネルギーの適正化！

適正エネルギー摂取量 (kcal)

$$= \text{標準体重 (kg)} \times 25 \sim 30 \text{ (kcal)}$$

例)

$$56.3 \text{ (kg)} \times 25 \sim 30 \text{ (kcal)}$$

$$\div 1,400 \sim 1,680 \text{ (kcal)}$$

BMI (Body Mass Index : 体格指数)

肥満の判定に使われる指標

【日本肥満学会の診断基準】

18.5未満

18.5以上 25.0未満

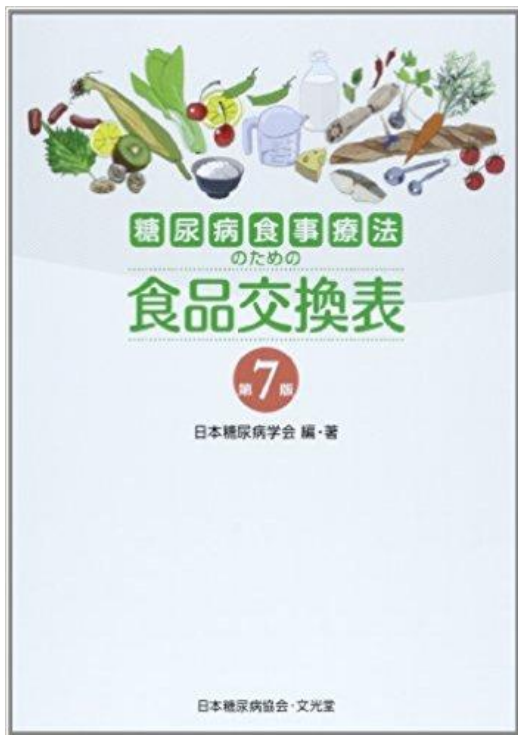
25.0以上

あなたの BMI は？

体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

栄養素のバランスがよい食事

糖尿病食事療法のための食品交換表 — 日本糖尿病学会編 —



☆ 1 単位 = 80 kcal

表 1 … 穀物、いも、炭水化物の多い野菜など

表 2 … くだもの

表 3 … 魚介、肉、卵、チーズ、大豆

表 4 … 牛乳と乳製品（チーズを除く）

表 5 … 油脂、多脂性食品

表 6 … 野菜、海藻、きのこ、こんにゃく

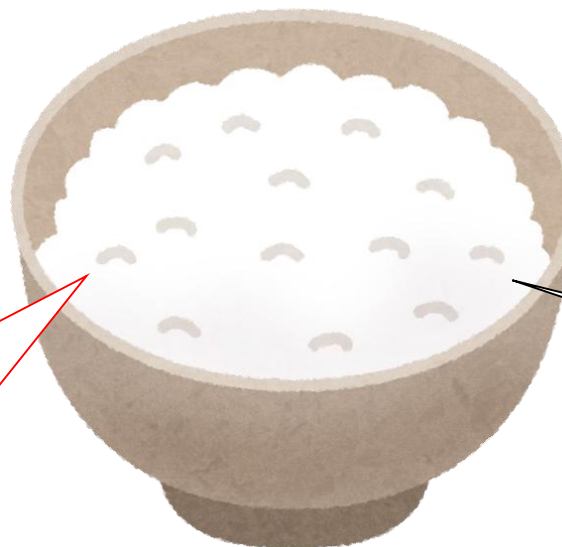
調味料 … みそ、砂糖、みりんなど

ごはん 100g のエネルギーは？

糖尿病食事療法のための

食品交換表

ごはん 50g
= 1 単位



炭水化物
37.1g

脂 質
0.3g

たんぱく質
2.5g

エネルギー (kcal) は？

$$80\text{kcal} \times (100\text{g} \div 50\text{g}) = 160\text{kcal}$$

食品交換表を使用するメリット

「表1」～「表6」を適宜配分することで、
栄養素の調整を考えなくても自然と栄養素のバランスがとれる

食品交換表のルール

同じ表の食品は同じ単位ずつ交換できる。

「表1」 ごはん50g $\longleftrightarrow$ 「表1」 食パン6枚切り1/2枚 (30g)

ただし、違う表の食品とは交換できない。

「表1」 ごはん50g $\nleftrightarrow$ 「表3」 もめん豆腐100g



1日の指示単位の配分例

— 1日20単位 (1,600kcal) の場合 —

食品交換表	表1	表2	表3	表4	表5	表6	調味料
食品の種類	穀物 いも 豆など	くだもの	魚介 大豆 卵 チーズ肉	牛乳 など	油脂 多脂性 食品 など	野菜 海藻 きのこ こんにゃく	みそ みりん 砂糖 など
炭水化物 60%	10	1	4.5	1.5	1	1.2	0.8
炭水化物 55%	9	1	5	1.5	1.5	1.2	0.8
炭水化物 50%	8	1	6	1.5	1.5	1.2	0.8

炭水化物の割合を55%にすると… 50%にすると…

たんぱく質が標準体重1kgあたり1.2gを超える場合があるので、腎症2期以降の方は注意が必要！

炭水化物量が少ないと脂質の摂取過多につながってしまう恐れあり

1 日の指示単位の配分例（エネルギー別）

— 炭水化物の割合60% の場合 —

配分例	表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6	調味料
1200kcal (15単位)	7	1	2.5	1.5	1	1.2	0.8
1440kcal (18単位)	9		3.5				
1600kcal (20単位)	10		4.5				
1840kcal (23単位)	12		5		1.5		

1 日20単位 (1,600kcal) 炭水化物60%の場合

	表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6	調味料
食品の 種類	穀 物 い も 豆など	くだもの	魚介 大豆、卵 チーズ 肉	牛乳 など	油脂 多脂性食品 など	野菜 海藻 きのこ こんにゃく	みそ みりん 砂糖 など
目標 単位	10	1	4.5	1.5	1.0	1.2	0.8
朝	3	1	1	1.5	1.0	0.4	0.8
昼	4		1.5			0.4	
夕	3		2			0.4	
間食							

食後血糖を最も上昇させる「炭水化物又は糖質」に着目した食事療法

カーボは「炭水化物（＝糖質）」、カウントは「数える」という意味

10gの炭水化物（又は糖質） ＝ 1カーボ

基礎カーボカウント

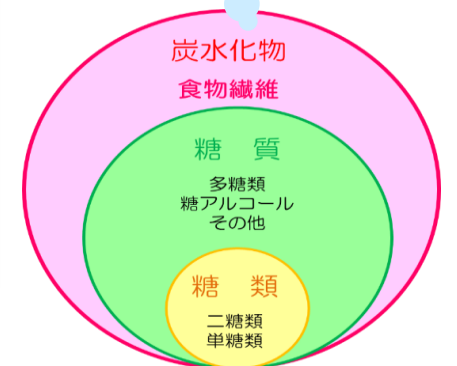
指示された炭水化物量をカウント 3食均等にすることで食後血糖値を安定

応用カーボカウント

炭水化物摂取量に合わせてインスリン量を調整

主に1型糖尿病患者に用いる

炭水化物＝食物繊維＋糖質
食物繊維は血糖には変わらないため、
食物繊維が分かる食品は、糖質だけをカーボカウントする



炭水化物量を把握することと糖質制限のちがい

食事に含まれる炭水化物の適正な配分は摂取エネルギーの50～60%です。食後の血糖値は主に食事に含まれる炭水化物（厳密には糖質）の量によって変動するので、血糖コントロールを行ううえで、食事中にどれだけ炭水化物（糖質）量が含まれているかを把握することは大切です。

ただし、この考えが糖質制限食に結びつくことがあり注意が必要です。極端な糖質制限食は長期的には腎症や動脈硬化の進行などが懸念され、決して勧められません。

- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

1 適正なエネルギー量をとりましょう

体の機能を維持する

2 たんぱく質をひかえましょう

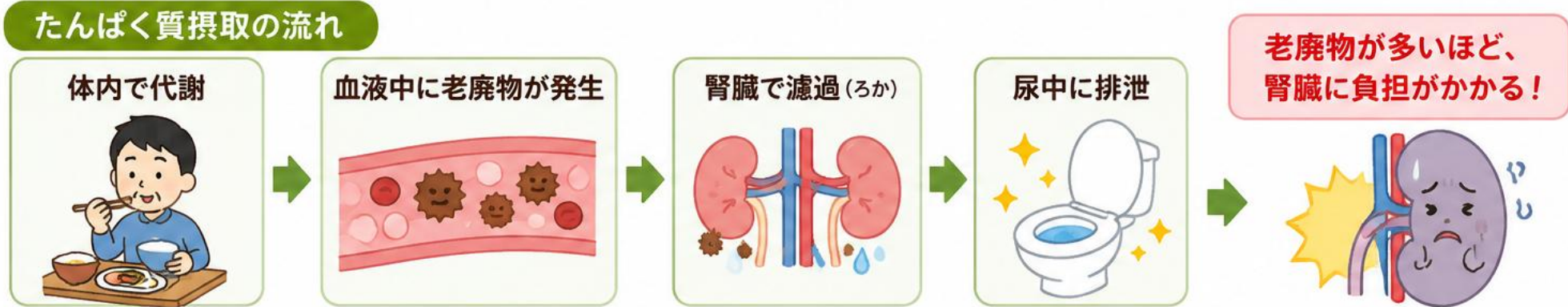
老廃物を濾過する負担を減らす

3 塩分をひかえましょう

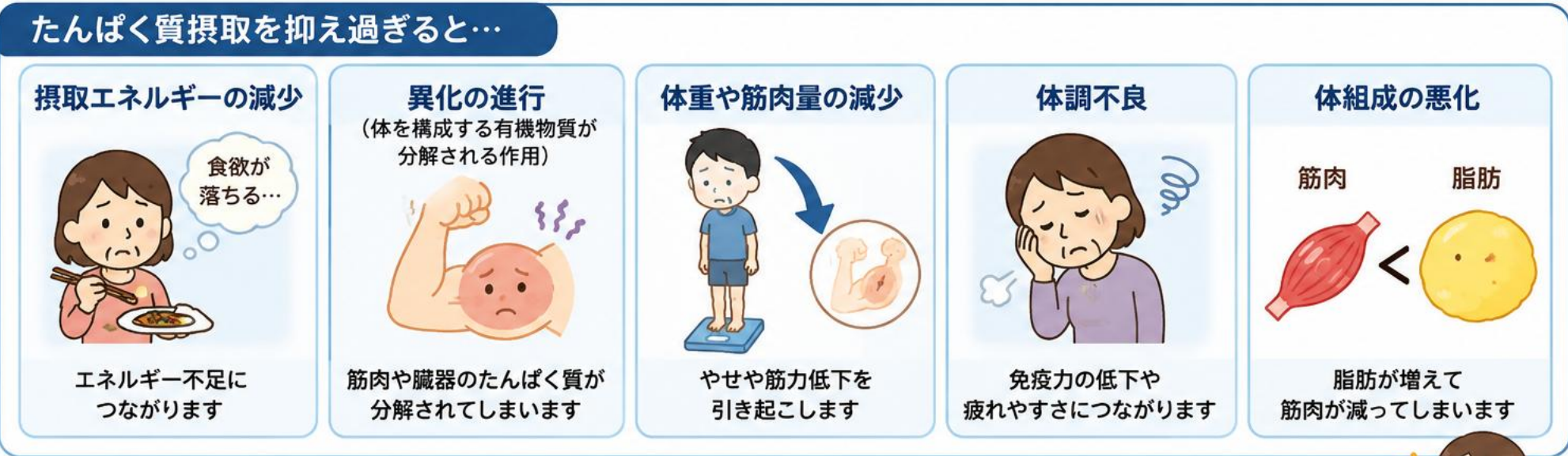
体内の水と塩分（ナトリウム）の量の調節を助ける

たんぱく質のコントロールは重要！

たんぱく質摂取の流れ



たんぱく質摂取を抑え過ぎると…

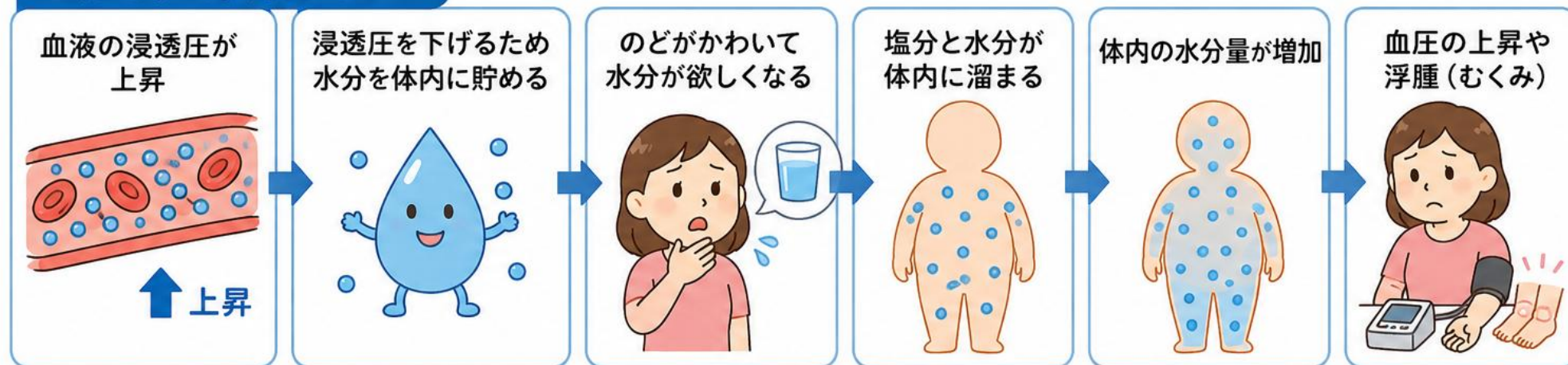


腎機能を低下させず、かつ体調を維持することが大切！

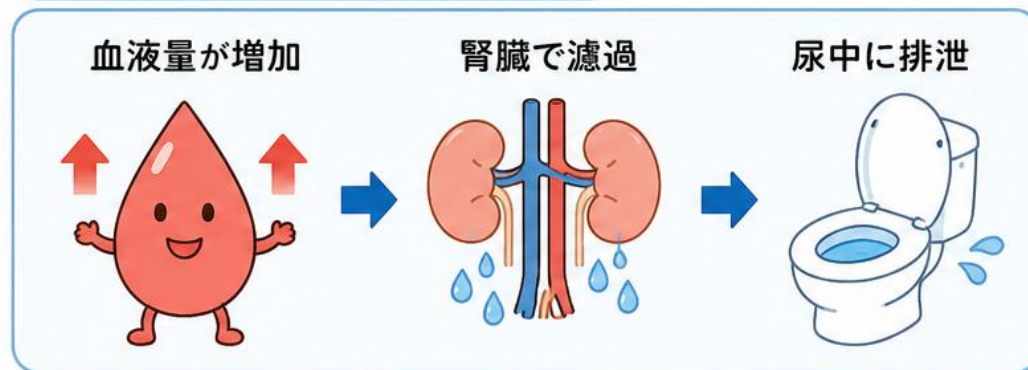


食塩（ナトリウム）と水分の関係

塩分を多く摂取すると…



体内の水分量が増加すると…



腎機能が低下すると…



塩分のとりすぎは、体に水分をためこみ、**腎臓に負担をかけます！**



カリウム

- 細胞内液の浸透圧を一定に保つように働いている。

細胞内の水分バランスを保つ！



- ナトリウム排泄作用により、血圧を正常に維持する。



- 腎臓でナトリウムが再吸収されることを抑制し、ナトリウムと尿と一緒に体外へ排泄する働きがあるので、体内の余分なナトリウムを減らすことができる。

ナトリウムの再吸収を抑制！

Na⁺

尿と一緒に体外へ排泄！



- 野菜類、海藻、きのこ類、いも類、豆類、果物などに多く含まれる。

野菜類



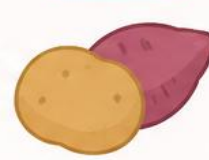
海藻



きのこ類



いも類



豆類



果物



- ゆでる、水にさらすなどの料理法で含有量は減少する。

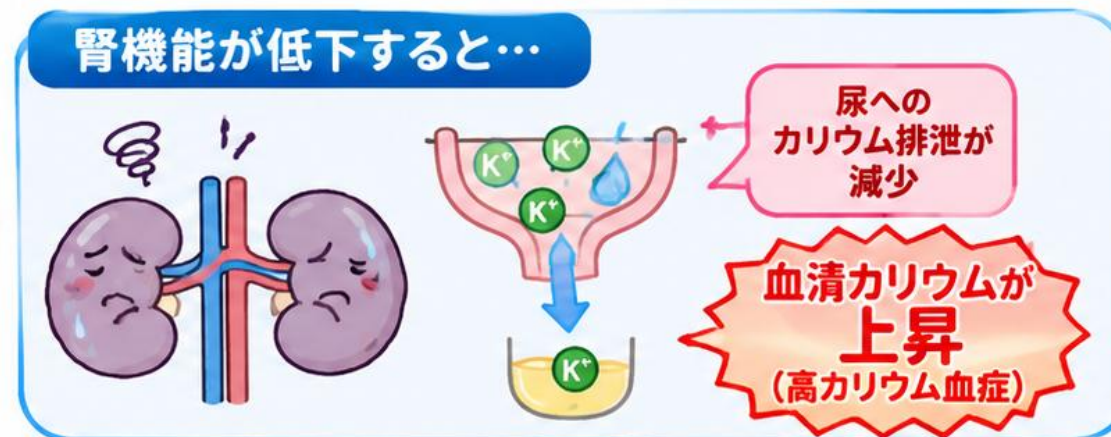
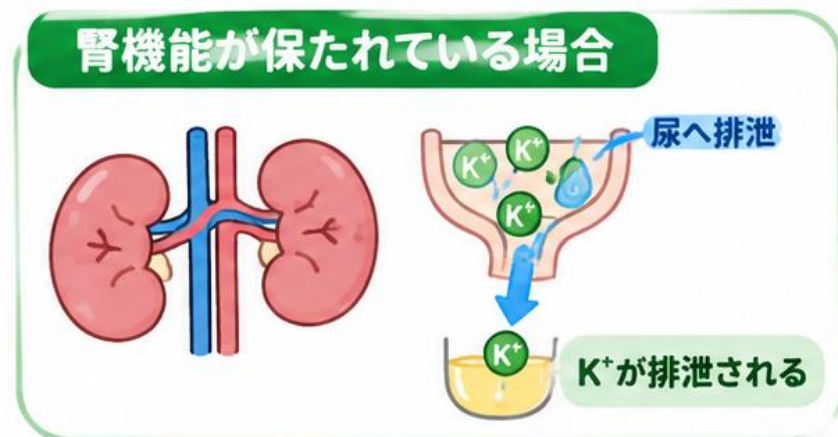
ゆでる



水にさらす



カリウムの含有量が減少！



腎機能が低下すると、カリウムをうまく排泄できず、体内に蓄積しやすくなります。



腎機能が低下しているときは、**カリウムの摂取量に注意**が必要です！

- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

栄養サポート方法

まずは、**口から食べる（経口摂取）**が大事

“If the gut works, use it !
” “使えるなら腸を使え！”



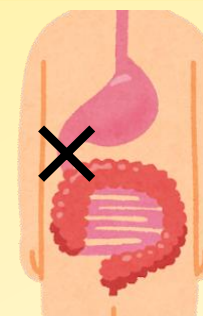
食欲不振等で
食べられない場合



経腸栄養を選択する



通過障害等で
消化管が使用できない場合



栄養障害があれば

中心静脈栄養の適用



経口摂取できない場合の栄養管理選択

栄養評価で栄養治療の必要あり



消化管を安全に使用できる？

YES



経腸栄養

短期

経鼻胃チューブ
経鼻十二指腸チューブ
経鼻腸チューブ

長期

胃瘻 (PEG)
腸瘻 (PEJ)

NO

経静脈栄養

2週間
未満

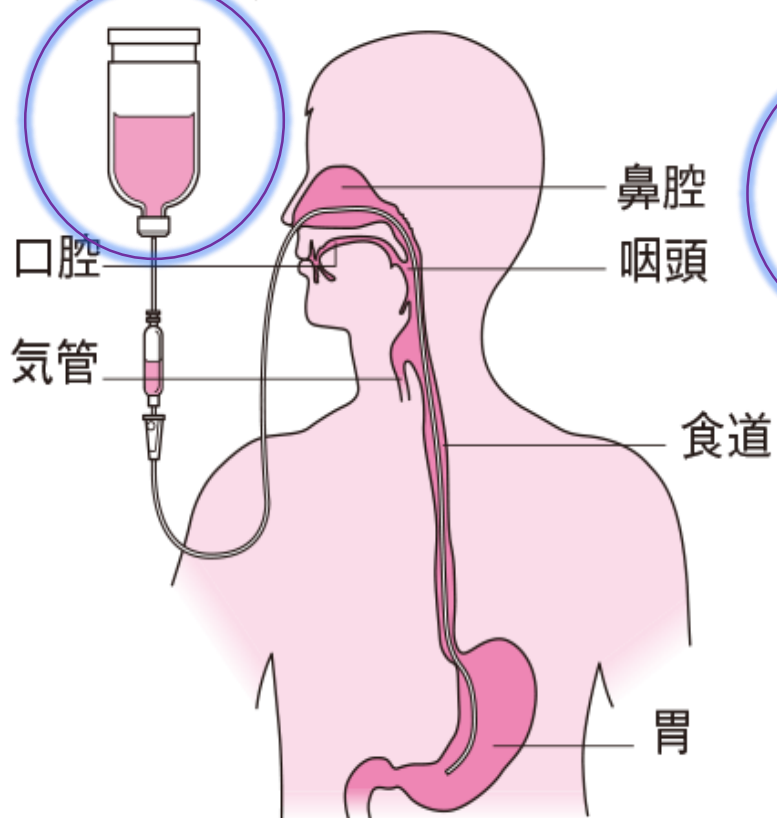
末梢静脈
(PPN)

2週間
以上

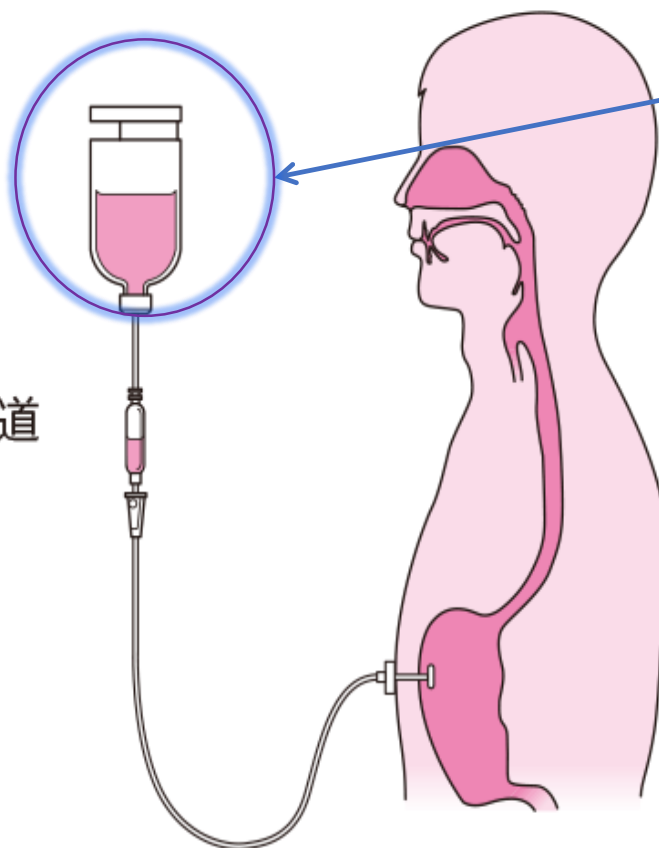
中心静脈
(TPN)

経腸栄養

経鼻胃管栄養



胃瘻栄養 (PEG)

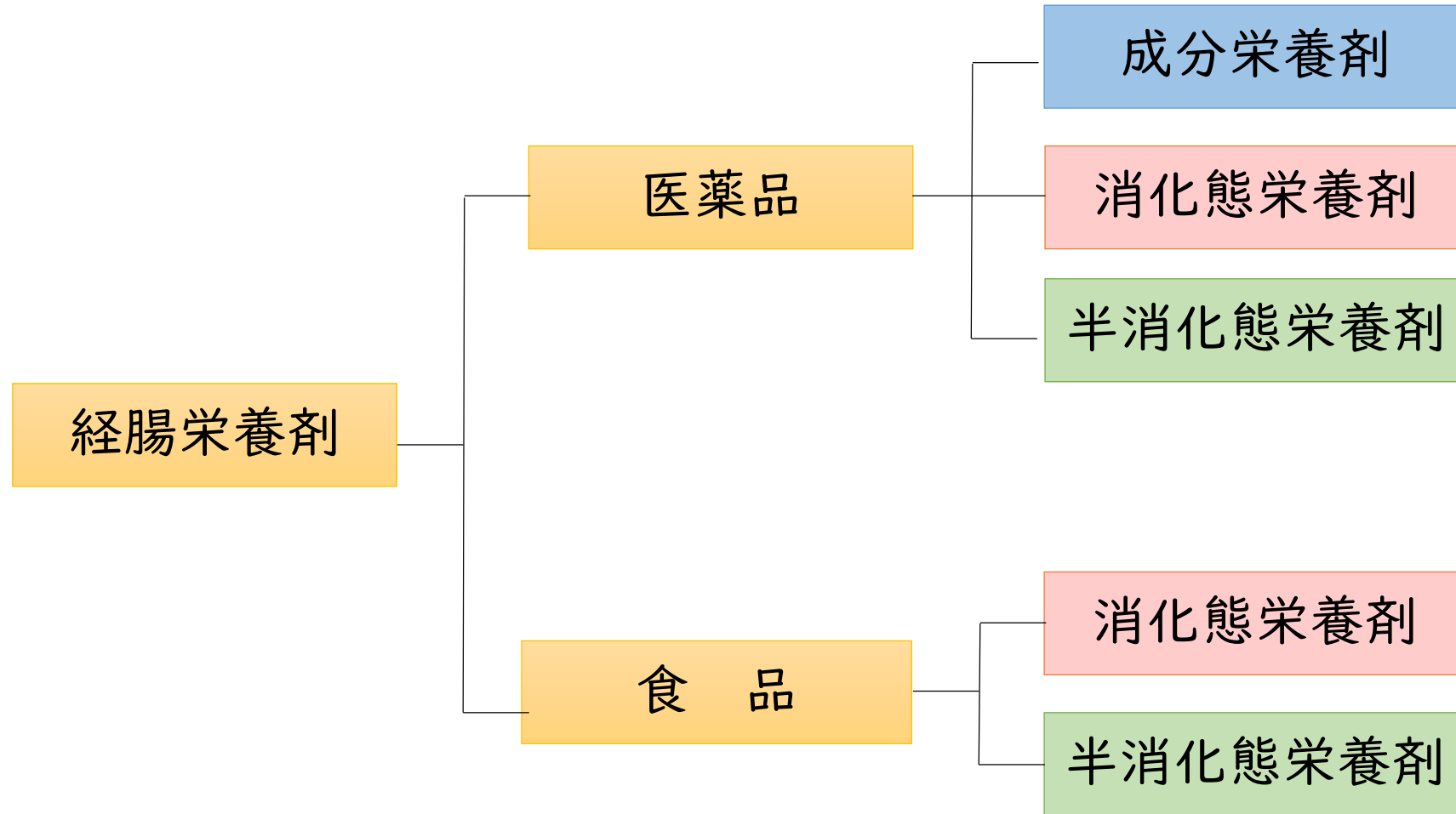


医薬品or食品の経腸栄養剤をボトルに移してから栄養を投与する。

(移し替え不要のバックタイプもあり)

栄養剤の組成は3種類に分類され、それぞれに特徴がある！

経腸栄養剤の種類

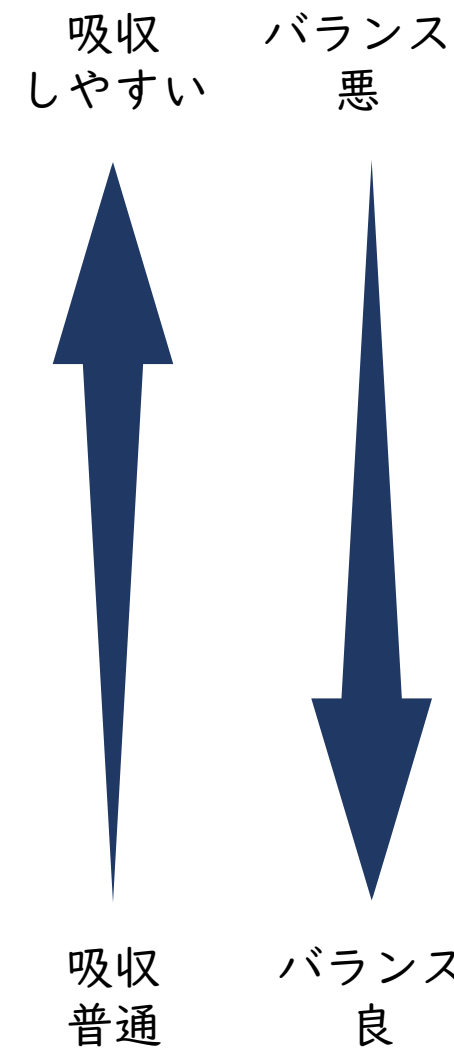


医薬品と食品の2種類がある！！

	医薬品	食 品
法 規	薬事法	食品衛生法
製造条件	医薬品製造承認の取得	なし
診療報酬上の 取り扱い	医薬品	入院時食事療養費
<u>保険適用</u>	<u>あり</u>	<u>なし</u>
<u>個人購入</u>	<u>不可</u>	<u>可</u>
管 理	薬剤部門	栄養部門

経腸栄養剤の特徴

成分栄養剤	すべての成分が化学的に明らかなものから構成 大きな特徴は窒素源が結晶アミノ酸のみで構成されていること 全ての成分が上部消化管で吸収され残渣はないとされている きわめて低脂肪のため、脂肪乳剤の併用が必須 【主な適応】 短腸症候群、重症膵炎に対する早期経腸栄養 クローン病に対する寛解導入・寛解維持療法など
消化態栄養剤	基本的に成分栄養剤とほぼ同等 窒素源がアミノ酸やタンパク水解物または小ペプチドからなる ペプチーノ以外の消化態栄養剤は脂肪が含まれている 【主な適応】 消化吸収機能が著しく低下、長期間絶食後の経腸栄養 クローン病に経腸栄養を施行する場合など
半消化態栄養剤	窒素源がタンパク質(多くはカゼイン)からなる 主に消化器の安静を必要としない状態に使用 食事から摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食 【主な適応】 脳血管障害や神経疾患、上部消化管の通過障害など



経腸栄養剤（薬品）

消化態（成分）栄養剤



ヘパンED
配合内用剤
（肝不全用）



ツインラインNF
配合経腸用液



エレンタール
配合内用剤



エレンタールP
乳幼児用
配合内用剤

半消化態栄養剤



ラコールNF
配合経腸用液



ラコールNF
経腸用半固形剤
（適応：胃瘻）



エンシュアH



エネーボ
配合経腸用液



アミノレバンEN
配合散（肝不全用）

半消化態栄養剤

1.0kcal/ml



メイバランス1.0



インスロー
（血糖管理）



グルセルナREX
（血糖管理）

1.5～1.6kcal/ml



アイソカルサポート
（水分調整）



リーナレンMP
（腎疾患）



リーナレンLP
（腎疾患）

2.0kcal/ml



テルミール
2.0α
（水分調整）



アイソカル100
（水分調整）



GFO
絶食時等の
腸管粘膜萎縮予防

経腸栄養剤（食品）



ペプタメン
スタンダード
（消化態）



ペプタメンAF
（消化態）



ヘバス
（肝疾患）



ハイネーゲル
（消化態半固形）



インパクト
（術前免疫賦活）

アップリード
（超高濃度栄養飲料）



REF-P1
（半固形化剤）



リハたいむゼリー
（主にたんぱく質補給）



バイ・クレスCP10



キャロラクト-F
（食物繊維・乳酸菌補給）



オルニユート
（創傷治癒促進）



経管栄養の合併症

☆ 下痢・嘔吐・腹部膨満がよくみられる 特に導入時に多い。

下痢が最も多いトラブル

投与速度が速いことが主な原因

速度は100～200ml/hを目安に、特に開始時はゆっくり投与する

その他、栄養剤の組成や濃度、浸透圧、温度によって起こることもある

チューブが原因のトラブル

チューブ汚染を予防するため、栄養剤投与後に20～30mlの微温湯でフラッシュして汚染を予防する。

経鼻胃管の場合、

鼻腔出血、痛み、嘔声、鼻管炎、チューブ固定の皮膚炎症にも注意

胃瘻の場合

瘻孔部周囲の皮膚の発赤、感染兆候、びらんや栄養剤の漏れに注意



- 1 はじめに
- 2 病院の食事
- 3 糖尿病の食事
- 4 慢性腎不全の食事
- 5 経腸栄養剤
- 6 名古屋市立大学病院の食事

大きく分類すると… 21種類

エネルギーコントロール食	幼児・小児食	ハーフ食
NEST食	たんぱくコントロール食	水分・カリウムコントロール食
脂肪コントロール食	コレステロールコントロール食	繊維コントロール食
術後食	胃切除食	離乳食
ミキサー食	嚥下調整食	加熱食
低菌食	検査食	個人名称食
調乳食	流動食（食品調整タイプ）	流動食（製品タイプ）※

細かく分類すると 110種類以上ある

- ☆ 1日の総摂取エネルギー別に調整された食事
- ☆ 各エネルギーごとに、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルのバランスを考えたもの

適応疾患

①制限的に用いる場合

糖尿病、肥満症、脂肪肝、急性肝炎、**心臓病**など

②一般食の栄養基準程度の場合

慢性肝炎、**肝硬変（代償期）**、**高血圧症**、痛風、貧血など

③高エネルギー食として用いる場合

甲状腺機能亢進症、神経性食思不振症など

600kcal/食



ご飯
酢豚
なすのスープ煮
果物（柿）

※赤字：塩分制限が必要

たんぱく質コントロール食

☆ 1日の給与総たんぱく質を調整した食事

☆ 主として腎疾患、肝疾患に使用され、塩分制限あり。

適応疾患

①制限的に用いる場合

肝硬変非代償期、肝不全

慢性腎不全、急性腎不全、糖尿病性腎症など

②一般食の栄養基準程度の場合

ネフローゼ症候群、透析、低栄養など

600kcal P13g/食



低たんぱくご飯
福袋
なすのスープ煮
果物（柿）

たんぱく質制限をしても食事の
クオリティーを維持するため、
特殊食品を利用することが多い！！

主食の栄養価（比較）

	エネルギー kcal	たんぱく質 g	カリウム mg	リン mg	食塩相当量 g
ごはん 精白米 150 g	252	3.8	44	51	0.0
低たんぱく ごはん1/10 150 g	251	0.4	3	19	0.0
食パン 6枚切 1枚 60 g	158	5.6	58	50	0.8
低たんぱく パン 1枚 50 g	162	1.5	19	17	0.2

腎臓病の治療用特殊食品（たんぱく質調整の主食）

ごはん	パン
パックタイプ トレイタイプ 炊飯タイプ	食パン クロワッサン ロールパン 冷凍パン
めん類	その他
乾めん カップめん 冷凍めん	おかゆ もち パンミックス

腎臓病の治療用特殊食品（エネルギー補給）

中鎖脂肪酸製品（MCT）

通常の油脂食品の長鎖脂肪酸と比べて脂っこくなく、胃もたれをせず、下痢しにくい。
門脈に吸収されるためエネルギー源になりやすく、体脂肪を増加させない。
たんぱく質を全く含有しない。



マクトンオイル



ニューマクトン
ビスキー



ニューマクトン
プチゼリー

菓子類

腎臓病用として、たんぱく質、エネルギー量、カリウム、リンなどに配慮した食品。
和菓子から洋菓子まで幅広い商品がある。



エネルギーコントロール食(一部抜粋)

食種	エネルギー-kcal/日	たんぱく質g/日	主食(ご飯)g/食	主菜g/食	塩分g/日	
エネコン1800	1,800	80	200	80	8.0	6.0
1600	1,600	75	150	80	8.0	6.0
1400	1,400	70	150	60	7.5	6.0
1200	1,200	65	100	60	7.5	6.0

たんぱくコントロール食(一部抜粋)

食種	エネルギー-kcal/日	たんぱく質g/日	主食(ご飯)g/食	主菜g/食	菓子	塩分g/日
タンコン6017	1,700	60	200	80	なし	6.0
5018	1,800	50	200	60	あり	6.0
5016	1,600	50	150	60	あり	6.0
4016	1,600	40	低蛋白150	60	あり	6.0
3014	1,400	30	低蛋白150	40	あり	6.0

- ごはんや水分がうまく食べられないことによる栄養状態低下（低栄養、脱水）
- 気道に食べ物が入ってしまい肺炎になってしまう（誤嚥性肺炎）、窒息する
- ごはんが食べられないことによる食べる楽しみの喪失

人間が生きる楽しみの一つ **口から食べる**こと

摂食障害があり、咀嚼も嚥下もできない ⇒ 経管栄養

【問題点】 消化酵素の分泌や唾液の分泌低下 免疫力の低下

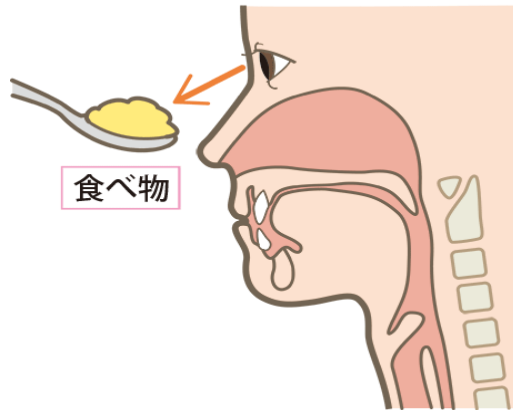
口から食べることが見直されている！！

嚥下が障害された時の食事や食品の開発・研究が進み、
経管栄養 から 経口栄養に移行しやすくなっている。

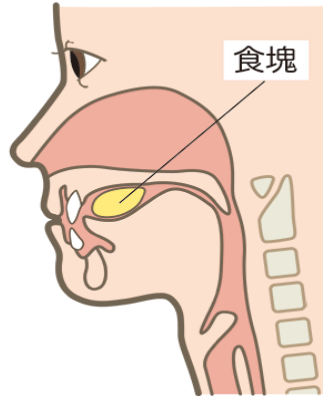
「咀嚼困難」 噛みづらい 「嚥下困難」 飲み込みづらい



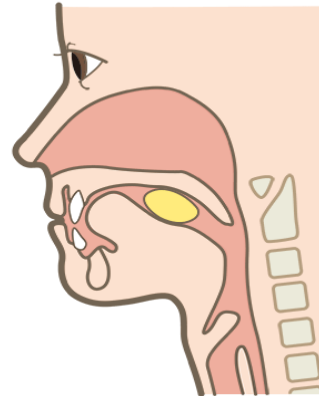
咀嚼・嚥下の過程（摂食嚥下の5期）



1. 先行期（認知期）



2. 準備期（咀嚼期）



3. 口腔期

第1相（先行期～口腔期）

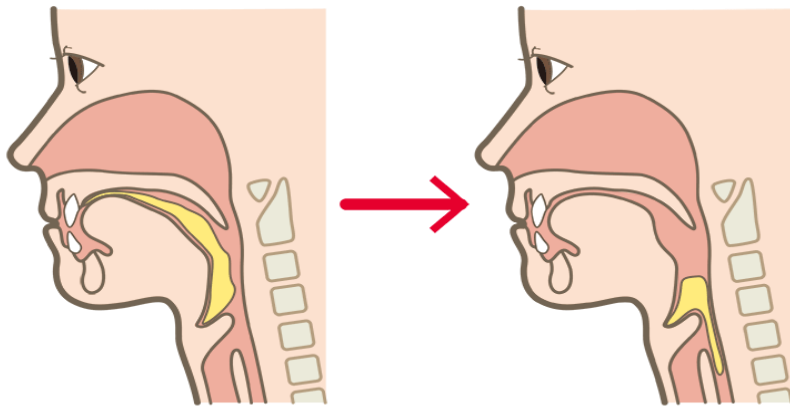
1. 食べ物を認知して口の中へ取り込む
2. 咀嚼して食塊形成する
3. 舌で咽頭に送り込む

第2相（咽頭期）

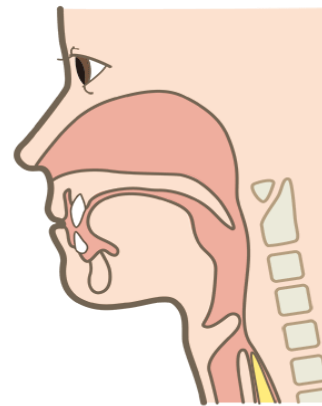
4. 咽頭通過、食道へ送り込む（嚥下反射）

第3相（食道期）

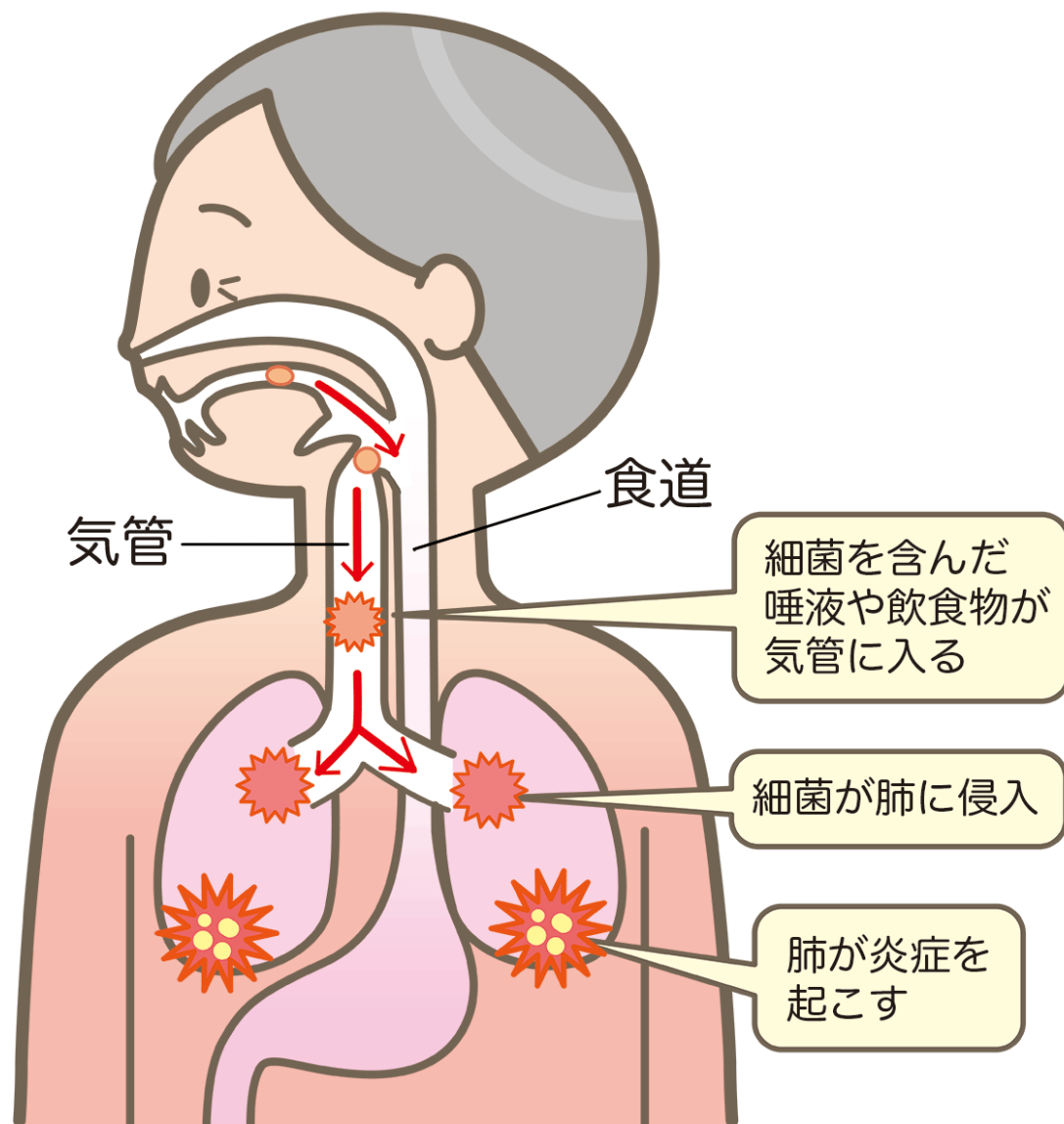
5. 食道の蠕動運動によって胃へ送り込む



4. 咽頭期



5. 食道期



誤嚥しやすいもの

パサパサして飲み込みにくいもの
液体のようにサラサラしたもの
口の中でボロボロして塊にくいもの
ペラペラしてはりつきやすいもの

誤嚥予防のための食事

滑らかでソフトな形状
トロっとしてまとまりやすいもの
均一な形態のもの

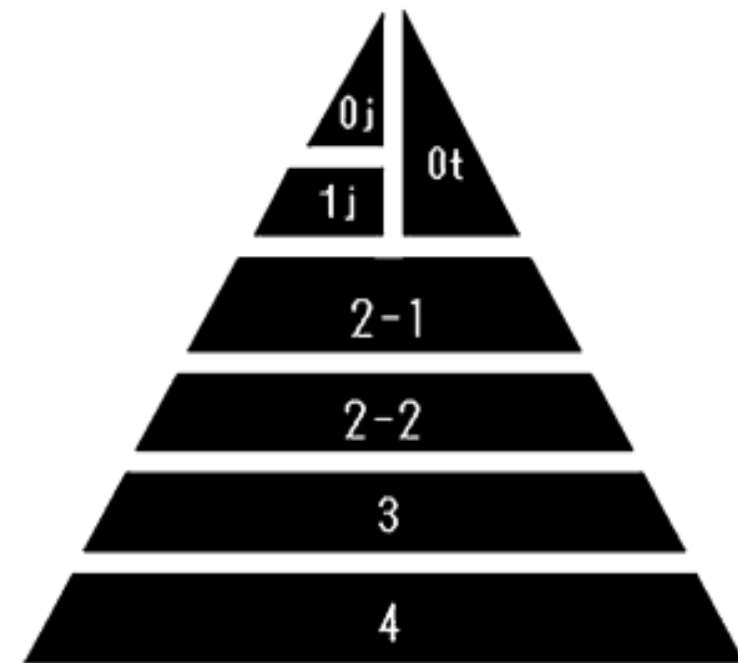
見た目よく、美味しいことも重要なポイント

嚥下調整食

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021

学会分類 2021 (食事) 早見表

コード 【1-8 項】	名称	形態	目的・特色	主食の例	必要な咀嚼能力 【1-10 項】	他の分類との対応 【1-7 項】
0	j 嚥下訓練食品 0j	均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したゼリー 離水が少なく、スライス状にすることが可能なもの	重度の症例に対する評価・訓練用 少量をすくってそのまま丸呑み可能 残留した場合にも吸引が容易 たんばく質含有量が少ない		(若干の送り込み能力)	嚥下食ピラミッド L0 えん下困難者用食品許可基準 I
	t 嚥下訓練食品 0t	均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したとろみ水 (原則的には、中間のとろみあるいは濃いとろみ* のどちらかが適している)	重度の症例に対する評価・訓練用少量ずつ 飲むことを想定 ゼリー丸呑みで誤嚥したりゼリーが口中で溶けてしまう場合 たんばく質含有量が少ない		(若干の送り込み能力)	嚥下食ピラミッド L3 の一部 (とろみ水)
1	j 嚥下調整食 1j	均質で、付着性・凝集性・かたさに、離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	口腔外で既に適切な食塊状となっている (少量をすくってそのまま丸呑み可能) 送り込む際に多少意識して口蓋に舌を押しつける必要がある 0j に比し表面のざらつきあり	おもゆゼリー、 ミキサー粥のゼリー など	(若干の食塊保持と送り込み能力)	嚥下食ピラミッド L1・L2 えん下困難者用食品許可基準 II UDF 区分 かまなくともよい (ゼリー状) (UDF: ユニバーサルデザインフード)
2	1 嚥下調整食 2-1	ビューレ・ペースト・ミキサー食など、均質でなめらかで、べたつかず、まとまりやすいもの スプーンですくって食べることが可能なもの	口腔内の簡単な操作で食塊状となるもの (咽頭では残留、誤嚥をしにくいように配慮したもの)	粒がなく、付着性の低いペースト状のおもゆや粥	(下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力)	嚥下食ピラミッド L3 えん下困難者用食品許可基準 III UDF 区分 かまなくともよい
	2 嚥下調整食 2-2	ビューレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質な物も含む スプーンですくって食べることが可能なもの		やや不均質 (粒がある) でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類	(下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力)	嚥下食ピラミッド L3 えん下困難者用食品許可基準 III UDF 区分 かまなくともよい
3	嚥下調整食 3	形はあるが、押しつぶしが容易、食塊形成や移送が容易、咽頭でばらけず嚥下しやすいように配慮されたもの 多量の離水がない	舌と口蓋間で押しつぶしが可能なもの 押しつぶしや送り込みの口腔操作を要し (あるいはそれらの機能を賦活し)、かつ誤嚥のリスク軽減に配慮がなされているもの	離水に配慮した粥 など	舌と口蓋間の押しつぶし能力以上	嚥下食ピラミッド L4 UDF 区分 舌でつぶせる
4	嚥下調整食 4	かたさ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの 箸やスプーンで切れるやわらかさ	誤嚥と窒息のリスクを配慮して素材と調理方法を選んだもの 歯がなくても対応可能だが、上下の歯槽提間で押しつぶすあるいはすりつぶすことが必要で舌と口蓋間で押しつぶすことは困難	軟飯・全粥 など	上下の歯槽提間の押しつぶし能力以上	嚥下食ピラミッド L4 UDF 区分 舌でつぶせる および UDF 区分歯ぐきでつぶせる および UDF 区分容易にかめるの一部



学会分類 2021 は、概説・総論、学会分類 2021 (食事)、学会分類 2021 (とろみ) から成り、それぞれの分類には早見表を作成した。
本表は学会分類 2021 (食事) の早見表である。本表を使用するにあたっては必ず「嚥下調整食学会分類 2021」の本文を熟読されたい。なお、
本表中の【 】表示は、本文中の該当箇所を指す。

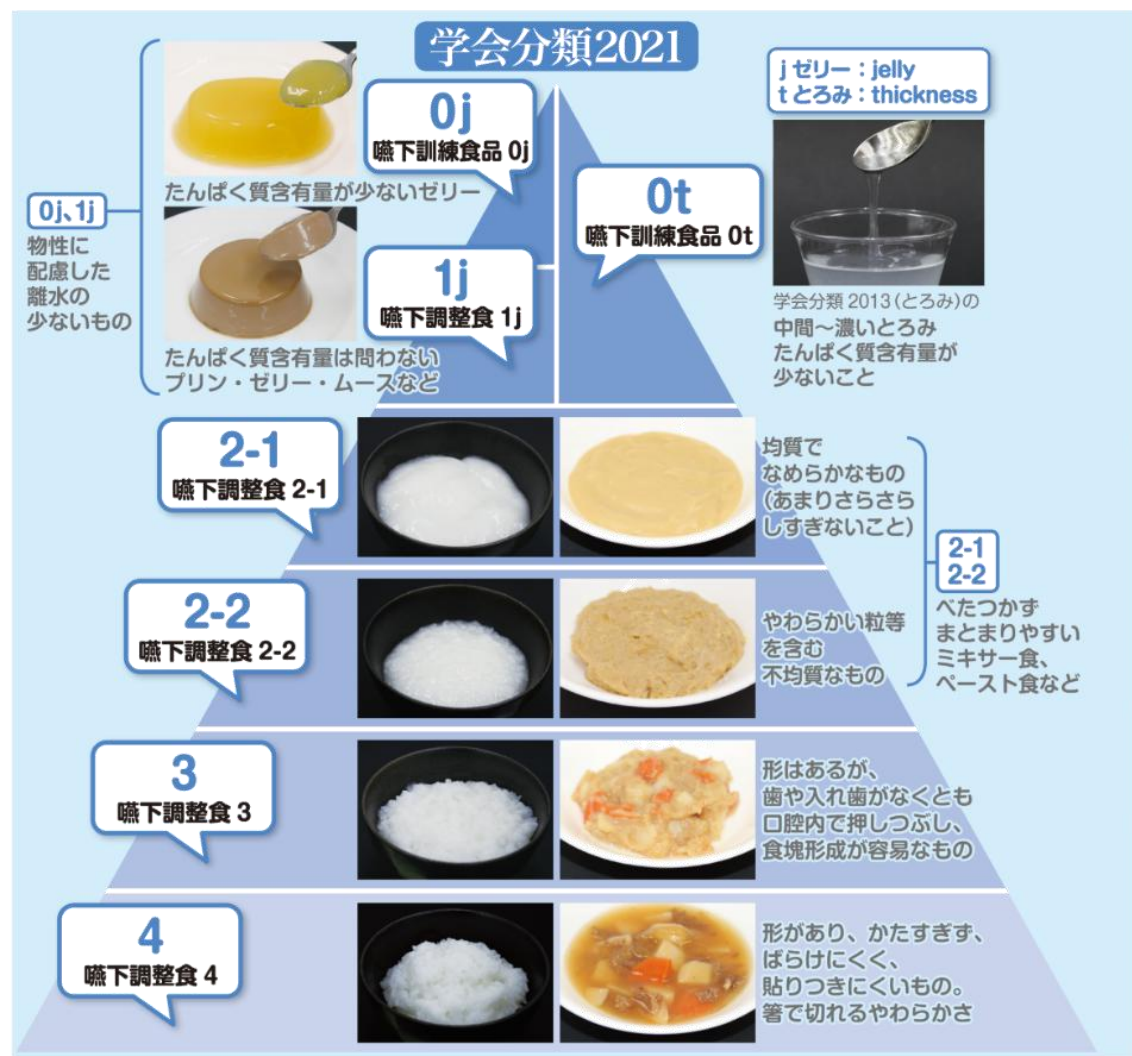
*上記 0t の「中間のとろみ・濃いとろみ」については、学会分類 2021 (とろみ) を参照されたい。

本表に該当する食事において、汁物を含む水分には原則とろみを付ける。【1-9 項】

ただし、個別に水分の嚥下評価を行ってとろみ付けが不要と判断された場合には、その原則は解除できる。

他の分類との対応については、学会分類 2021 との整合性や相互の対応が完全に一致するわけではない。【1-7 項】

咀嚼・嚥下食の統一分類



他分類				
学会分類2021	嚥下食ピラミッド	特別用途食品	UDF	スマイルケア食
0j	L0 (開始食)	許可基準 I	—	0
0t	L3の一部 (とろみ水)	—	—	0
1j	L1・L2 (嚥下食Ⅰ・Ⅱ)	許可基準 II	かまなくてよい	1
2-1	L3 (嚥下食Ⅲ)	許可基準 III	かまなくてよい	2
2-2	L3 (嚥下食Ⅲ)	許可基準 III	かまなくてよい	2
3	L4 (移行食)	—	舌でつぶせる	3
4	L4 (移行食)	—	舌でつぶせる 歯ぐきでつぶせる 容易にかめる (一部)	4

名市大病院 嚥下調整食

嚥下訓練開始ゼリー0j

嚥下ゼリー食1

嚥下ペースト食2

嚥下ソフト食3

嚥下移行食4

形態、特色などの詳細は「嚥下調整食分類2021」の本文及び学会分類2021(食事)早見表をご確認ください。

※他分類の対応に関して：嚥下食ピラミッド、えん下困難者用食品許可基準、UDF区分は「学会分類2021(食事)早見表」、スマイルケア食は「スマイルケア食の選び方(<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo.html>)」を参考に当社が作成したものです。

※学会分類2021に対応する内容のみ記載しておりますので、嚥下食ピラミッド「L5普通食」、スマイルケア食「B」、「青マーク」の記載は割愛しております。

※学会分類2021に対応していない場合は「—」を記載しています。

0j



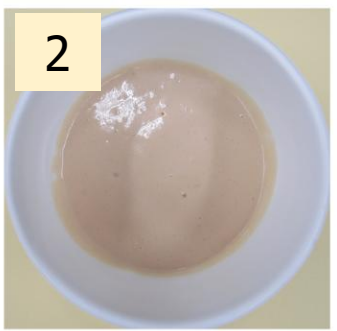
エンゲリード

1



果物ゼリー・ヨーグルト

2



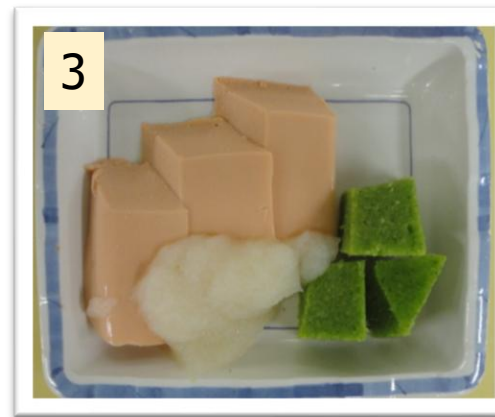
親子煮

3 4



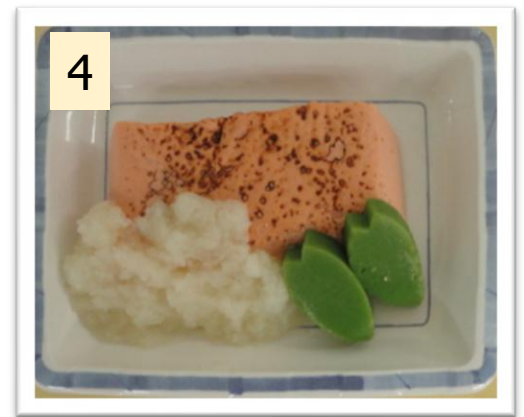
トマトゼリー

3

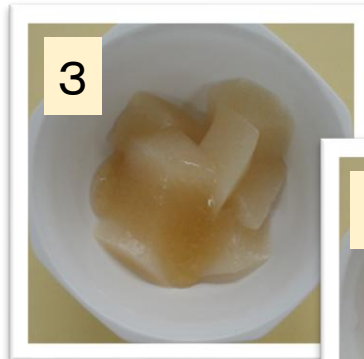


鮭の塩焼き（大根おろし、フロッコリー）

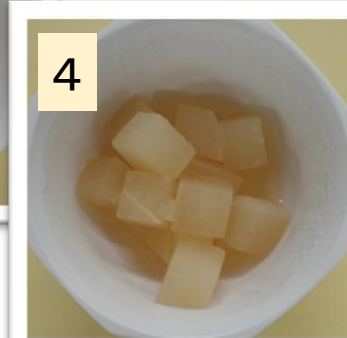
4



3

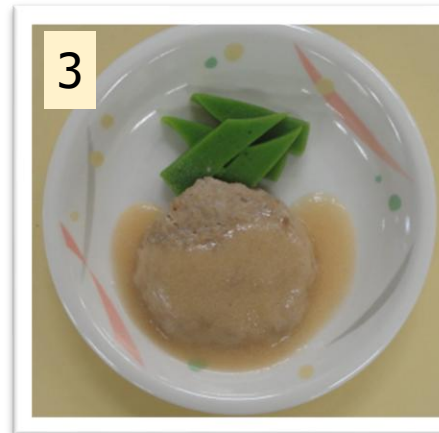


4



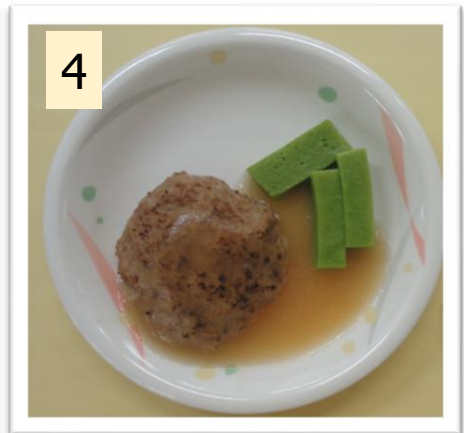
大根の含め煮

3



牛肉おろしソース（アスパラガス）

4



栄養サポートチーム (NST)

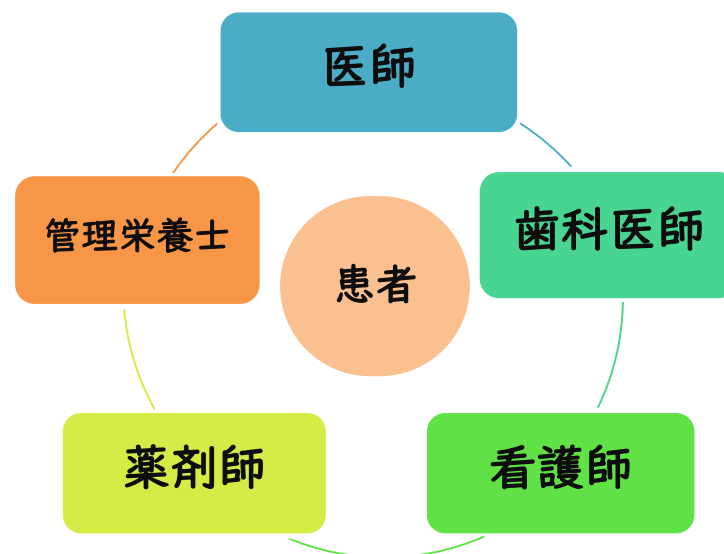
* Nutrition Support Team の略

医師・歯科医師を中心として、看護師・薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、診療放射線技師、管理栄養士などがそれぞれの**専門知識**を持ち寄って、チーム医療としての栄養管理を実施すること。

名市大病院 NSTオリジナルマーク



名市大では、専任医師1名（消化器外科）
各診療科から当番制で参加（月1回程度）



名市大病院 NSTチームメンバー



小川	医師
宮本	歯科医師
松山	歯科医師
吉田	看護師
瀧本	看護師
伊豆田	薬剤師
西垣	薬剤師
羽藤	薬剤師
庄司	言語聴覚士
森田	管理栄養士



Nutrition
Support
Team



栄養サポート チーム

が活動しています。

食事・経管栄養・点滴などの
栄養管理の相談にのります。

主治医、看護師にお声かけ下さい。

名古屋市立大学病院 栄養管理運営委員会



回診・カンファ日

水曜日



13時30分から

栄養サポートチームコアスタッフ

- 専任（医師、歯科医師、看護師、薬剤師）
- ◎専従（管理栄養士）



15時から

- 医師
（栄養管理運営委員会委員）
- メディカルスタッフ
（必要に応じて参加）



症状の選別・状態を確認



栄養アセスメント



栄養補給方法を決定、実施

繰り返し実施



チームで専門知識を持ち寄って
最適な栄養管理方法を選択していく

NST回診の流れ



コアスタッフカンファレンス
(報告患者中心)

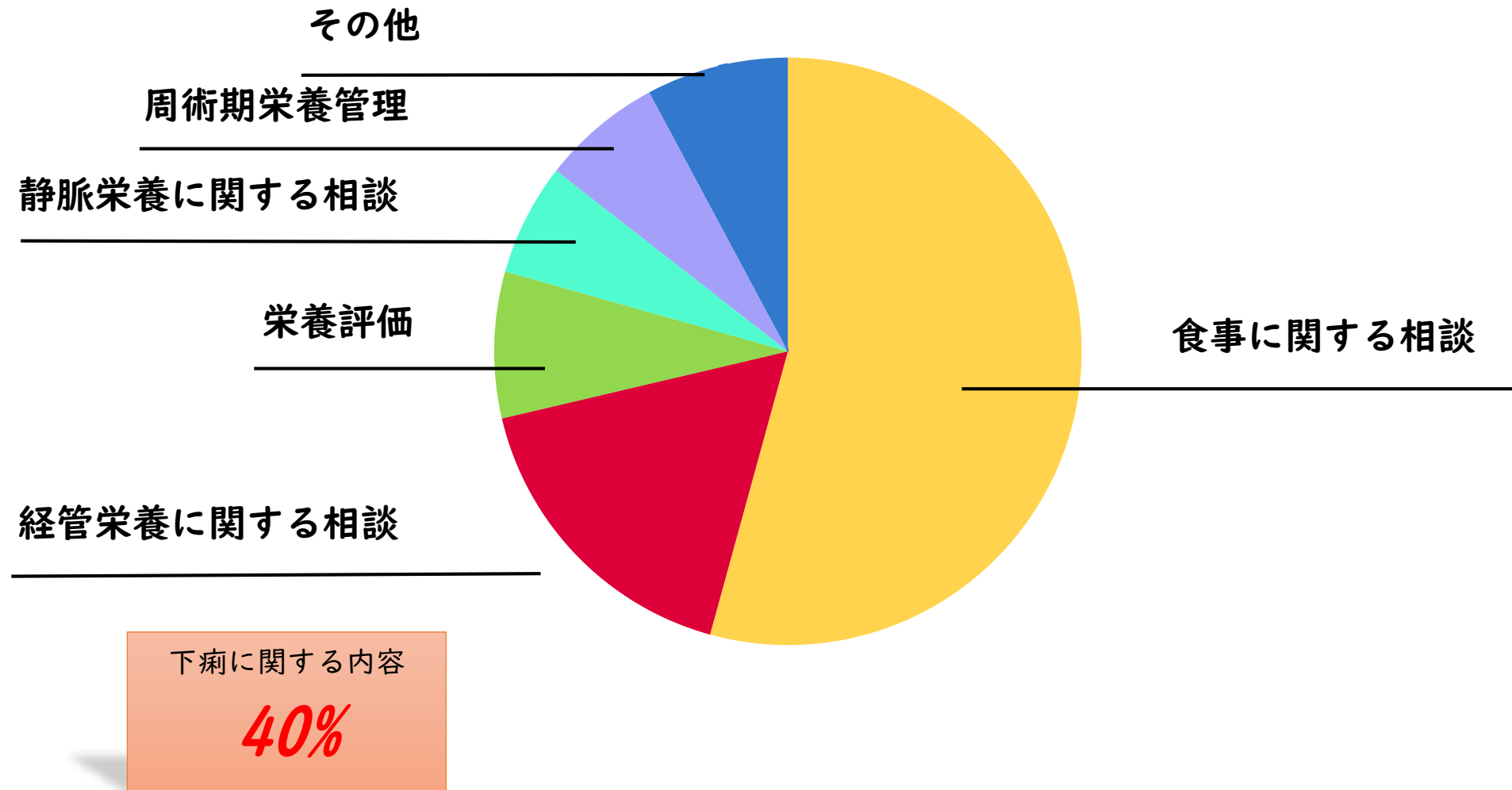


病棟カンファレンス
(新規患者・要検討患者中心)

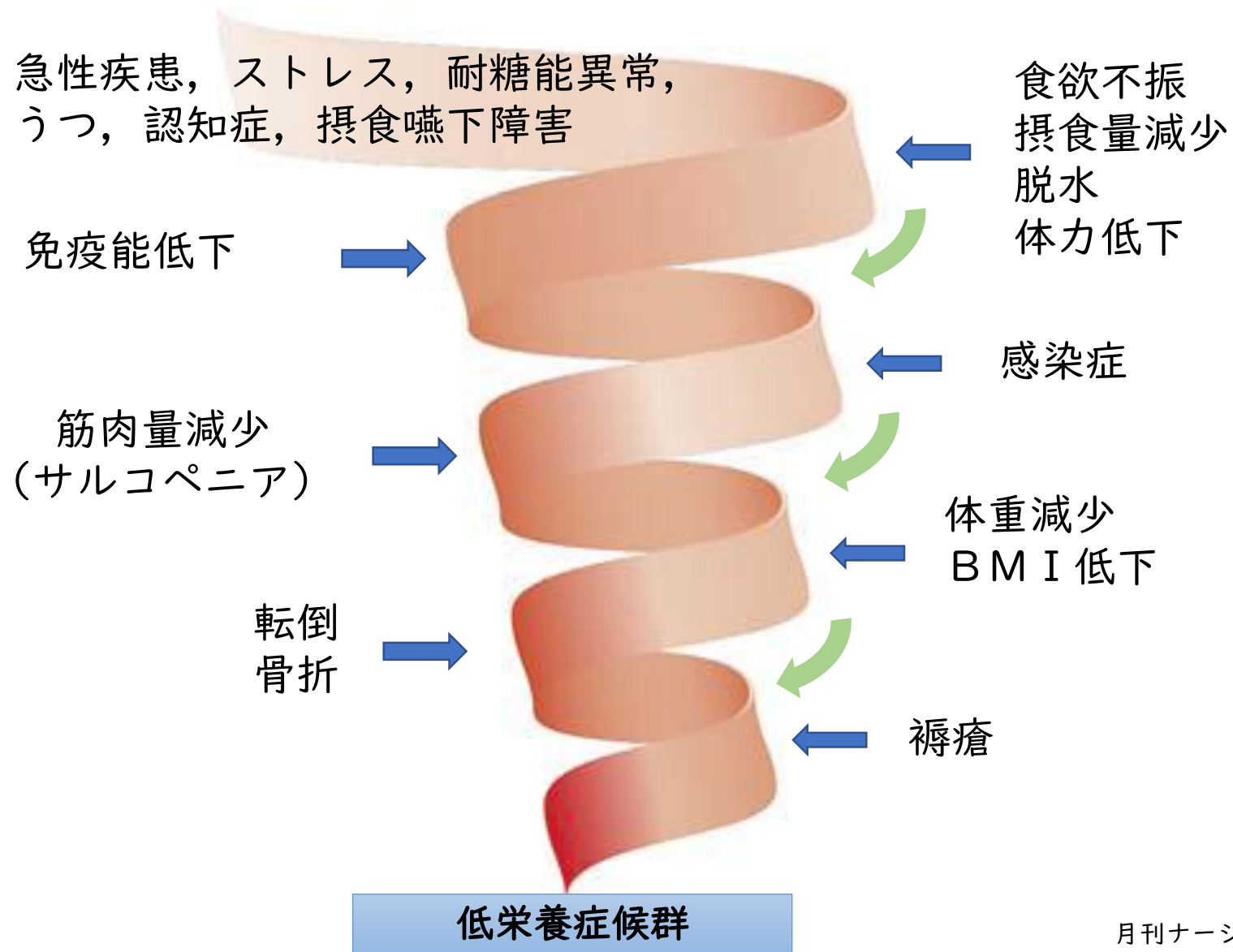


ベッドサイド訪問

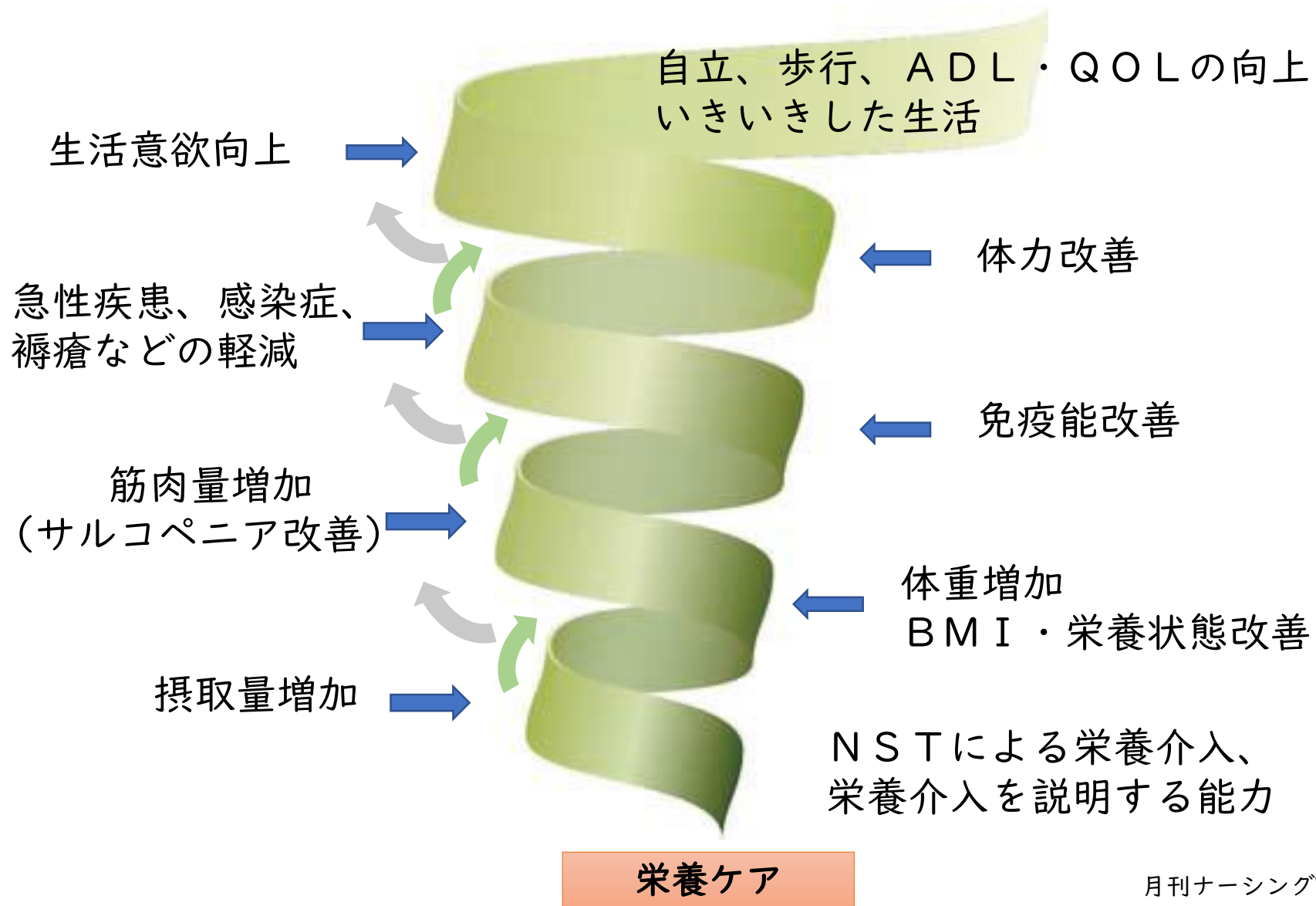
NST相談内容



栄養状態 負のスパイラル



栄養状態 正のスパイラル



青空に向かって！！

皆さんと一緒に
働けることを
楽しみにしています！！

